

服思密达:C 组 25 例口服奥美拉唑。疗程均为 4 周。治疗前,疗程结束时和结束 4 周后分别作胃镜和 HP 检查。结果:A、B、C 三组溃疡愈合率分别为 94%、78%和 88%,HP 根除率分别为 62%、32%和 4%。结论:思密达和奥美拉唑联合用,HP 根除率和溃疡愈合率均提高。

2 与雷尼替丁合用^[3]

用思密达和雷尼替丁联合治疗 PU,与单用雷尼替丁、奥美拉唑和胶体次枸橼酸铋进行了比较。结果:联合治疗 PU 4 周的愈合率均超过单用雷尼替丁及胶体次枸橼酸铋,与奥美拉唑相仿;在 HP 清除上,联合治疗的疗效与胶体次枸橼酸铋相仿,且长期服用无毒性作用,与铋剂相比有明显的优越性。思密达和雷尼替丁联合治疗 PU,既有制酸作用,又有保护胃粘膜作用,同时又有清除 HP 的作用,可避免溃疡复发,故有着较高疗效。

3 与柳氮磺胺吡啶合用^[4]

在应用柳氮磺胺吡啶等治疗的基础上,对 32 例溃疡性结肠炎病人加用思密达口服。观察结果显示,思密达治疗组 4 周的总有效率为 90.63%,优于对照组的 72.41%,且平均住院天数较后者少 7.4 d;腹痛消失、便次及性状的恢复时间明显优于对照组;里急后重症状的改善也优于对照组。思密达联合柳氮磺胺吡啶治疗溃疡性结肠炎,可尽快改善临床症状,缩短疗程,从而减少柳氮磺胺吡啶的用量,降低其不良反应。

4 与诺氟沙星合用

侵袭性细菌性腹泻一般主张采用有效抗生素治疗。单一思密达或诺氟沙星对侵袭性细菌性腹泻的治愈率分别为 83.78%和 87.93%。思密达联合诺氟沙星治疗后,临床症状(体温、便次、腹痛等)平均恢复时间缩短,治愈率可提高到 98.18%。通过血药浓度测定表明,思密达不影响诺氟沙星的吸收,可以同时服用^[5]。

5 与阿莫西林合用

采用口服思密达联合阿莫西林治疗小儿急性感染性腹泻 46 例。结果:联合治疗组症状、体征好转及消失天数与单用思密达对照组的疗效比较,差异显著;联合治疗组显效率、总有效率分别为 80.4%和 95.6%,而对照组分别为 52.5%和 72.0%,差异非常显著^[6]。表明思密达、阿莫西林联合治疗小儿急性感染性腹泻疗效高,病程短。

6 与叶酸合用

用思密达配伍叶酸治疗婴儿秋季腹泻 86 例,不用任何抗生素,酌情纠正酸中毒和补液。结果:86 例婴儿 48 h 内全部治愈^[7]。表明思密达联合叶酸治疗婴幼儿秋季腹泻起效快、疗程短,疗效明显提高。

7 与复方地芬诺酯合用

用思密达与复方地芬诺酯联合治疗病毒性肠炎。结果:治疗组疗程 3~7 d,平均 4.2 d;对照组疗程 3~10 d,平均 4.8 d。经统计学处理,差异有显著性($P<0.05$)^[8]。思密达治疗腹泻疗效肯定,复方地芬诺酯直接作用于肠平滑肌,减弱肠蠕动;同时加快肠节段性收缩,使肠内容物通过延迟,利于肠内水分吸收。联合应用疗程缩短。

8 与红霉素合用

在输注红霉素前 10 min,按常规量口服思密达,结果消除胃肠道反应的总有效率为 93.4%^[9]。对输注红霉素出现胃肠反应者,次日开始输注前 15~30 min 服用思密达,消除胃肠道反应的总有效率达 97.37%^[10]。静脉滴注红霉素前口服思密达,既能提高胃肠道粘膜的防御作用,又不影响胃肠正常功能及红霉素的药理作用,疗效可靠,无不良反应发生,可有效缓解及消除红霉素的胃肠道反应。

参考文献

- 1 姚吉弼.思密达临床应用评价[J].中华消化杂志,1996,16(4):226
- 2 李茂科,崔饮利,刘志强等.十六角蒙脱石和奥美拉唑合用治疗幽门螺旋杆菌感染的消化性溃疡[J].新药与临床,1997,16(6):324
- 3 李巍.十六角蒙脱石和雷尼替丁联合治疗消化性溃疡[J].中国新药与临床,1998,17(2):117
- 4 蔡永清,尹作述.思密达治疗溃疡性结肠炎[J].中级医刊,1995,30(3):153
- 5 方鹤松.综述消化道粘膜保护剂思密达治疗腹泻病的效果[J].中级医刊,1994,29(4):230
- 6 康宾阳,于彤军,吴敏等.思密达联合羟氨苄青霉素治疗小儿急性感染性腹泻病 46 例[J].新消化病学杂志,1997,5(4):249
- 7 陈培仁.思密达配合叶酸治疗婴幼儿秋季腹泻 86 例[J].福建医药杂志,1996,18(6):74
- 8 张寄平.思密达与复方地芬诺酯片联合治疗病毒性肠炎 44 例报告[J].中国实用儿科杂志,1998,13(2):98
- 9 喻莉,方俊明,刘青青等.思密达拮抗红霉素胃肠道反应观察[J].中国医院药学杂志,1997,17(2):65
- 10 刘戈力,初桂兰.思密达消除静脉滴注红霉素后的胃肠道不良反应的观察[J].天津医药,1997,25(11):692

收稿日期:1999-01-16

氯氮平的药物相互作用

陈福新,赵振声 (大理州精神卫生中心,云南 大理 671000)

中图分类号:R969.2 文献标识码:A 文章编号:1001-5213(2000)04-0233-03

氯氮平作为非典型抗精神病药,疗效高,锥体外系不良反应少见,病人易于接受,目前已广泛用于临床,其使用频率已超过氯丙嗪和奋乃静,位居第一^[1]。随着临床使用的增

加,与其他药物相互作用的机率也增加,作者根据有关文献综述如下:

1 氯氮平的药动学性质

本药易吸收,快速吸收型的达峰时间 ≤ 1.5 h,慢速型达峰时间为3~66 h,94%与血浆蛋白结合,经肝细胞色素P450 1A₂、2D₆代谢,代谢途径有环氧化物形成,硫酸化,葡萄糖醛酸化等^[2],生物半衰期($T_{1/2}$)3.6~14.3 h。在联合用药治疗时,诱导氯氮平代谢酶活性的药物可降低其效价,而抑制这些酶活性的药物则可增加其不良反应。

2 与药物的相互作用

2.1 抗癫痫药 氯氮平降低了抽搐阈值,能明显增加抽搐发生率,约11%服药病人有肌阵挛或大发作,且与剂量有关^[3],常导致医生使用抗癫痫药来预防。在一项开放性研究中,55例用丙戊酸加氯氮平者,有效率达87%,最常见的不良反应是过度镇静,遗尿、恶心、流涎、肝功能受损。二药联用的安全性和有效性尚不能确定,不过较多的文献认为合用很有必要^[4]。

有资料报道^[5],氯氮平合用卡马西平后患者的睡眠时间明显延长,且兴奋状态得到明显控制,近期疗效远优于单用组。但总的来说,两者不宜联用。氯氮平可影响血液系统,而卡马西平对造血系统亦有毒性,联用会增加粒细胞缺乏的危险,同时卡马西平是一个强效酶诱导剂,联用会降低氯氮平的血药浓度^[3,4]。二药联用前一定要仔细权衡用药的安全性和危险性,联用后,监测白细胞和血药浓度至关重要。

苯妥英是强效酶诱导剂,可增加细胞色素P450 3A₄及1A₂的活性,与氯氮平同用,使得氯氮平血药浓度大大降低,易导致精神症状恶化。苯巴比妥亦是酶诱导剂,可使氯氮平代谢加快,血药浓度降低,故不宜合用。

2.2 抗菌药物 大环内酯类抗生素红霉素是肝细胞色素P450 1A₂、3A₄的抑制剂,与氯氮平合用会增加氯氮平血药水平。据报道,合用红霉素诱发癫痫发作,其血浆氯氮平浓度显著升高^[2]。

氯霉素、磺胺类药物均有不同程度的药酶抑制作用,可使氯氮平血药浓度升高,且它们对造血系统均有毒性作用,合用时应适当减少氯氮平的用量,最好监测血药浓度和血象。

异烟肼、对氨基水杨酸均在肝脏代谢,经乙酰化而失活,是肝药酶抑制剂,可影响氯氮平的代谢,联用时宜谨慎。

2.3 选择性5羟色胺(5-HT)再摄取抑制剂(SSRIs) SSRIs如氟伏草胺、氟西汀、帕罗西汀、舍曲林可抑制肝细胞色素P450 2D₆、2C 3A,与氯氮平合用时,可影响其代谢,使氯氮平及其代谢物去甲氯氮平的稳态血药浓度显著升高^[6]。

2.4 锂盐 不管单用或联用,对于难治性双相障碍,氯氮平被认为是一种高效的心境稳定剂。但两药联用,已有引起神经毒性的报告,表现步态不稳,吐字不清,双手震颤,头晕,恶心、呕吐等类似醉酒症状^[7],尚有发生糖尿病酮中毒及恶性综合征的报告^[4]。

2.5 其它抗精神病药 有报告氯氮平与舒必利合用,患者突然昏倒,全身抽搐,呼吸心跳骤停^[8]。

利培酮对5羟色胺2(5-HT₂)和D₂受体均有拮抗作用,其对5-HT₂受体的亲和力比氯氮平高20倍^[9]而氯氮平对5-

HT和多巴胺能(DA)均有作用,两者合用可竞争结合受体,导致不良反应增加。有报告合用维思通(利培酮)引起发热,面色苍白,口唇发绀,呼吸急促,大量出汗,抽搐,意识模糊,尿失禁,肌张力亢进,白细胞升高等恶性综合征^[8]。

据报道^[10]联合应用氯氮平与氯丙嗪对精神分裂症阳性症状的治疗效果比单一用药更好。上海市精神卫生中心门诊用药调查发现合用占总处方的10.72%^[11]。但两药合用时,氯氮平血浓度平均升高74%,其机理可能是氯丙嗪的抗胆碱作用延缓了氯氮平的吸收,同时竞争载体,使氯氮平进入中枢的量减少而留在血中浓度升高^[11],进而增加其临床疗效和毒性作用,联用时宜慎重。据报道^[12]观察12例合用氯丙嗪和氯氮平者,发现氯氮平血浓度升高显著,血浓度增高和血压下降有关。

2.6 烟草 烟草中的主要成份是尼古丁,可影响药物代谢,多环芳香烃是很强的肝药酶诱导剂,可加速药物的代谢。据报道^[13]对90例吸烟与非吸烟精神分裂症患者进行氯氮平剂量、血浓度、疗效等作相关性研究,发现吸烟者氯氮平剂量显著高于非吸烟者,而血浓度前者显著低于后者,疗效后者优于前者。接受氯氮平治疗期间应禁止吸烟。

2.7 雌激素、孕激素 据报道^[14]对氯氮平在女性月经周期中代谢规律进行研究,结果发现月经周期过程对氯氮平代谢有显著影响,雌、孕激素水平升高,胃排空加快,小肠粘膜吸收率提高,肝药酶的活性下降,使血浓度升高,同时雌激素有抗多巴胺作用;雌、孕激素水平下降,则使血浓度降低,导致病情反复。联用时应注意血药浓度的变化,以避免不良反应的发生。

2.8 其他药物 与氯丙咪嗪合用有报告易引起癫痫发作^[7]。据报道与多虑平合用,小剂量可治疗氯氮平引起的流涎,但两药均有抗胆碱能作用,合用宜谨慎。与氯硝西洋联用,曾有2例报告引起心包积液,1例引起急性肺水肿^[15]。与电抽搐治疗合用,有资料显示谵妄发生率为16%,与对照组差异显著^[15]。此外,咖啡因作为肝细胞色素P450 1A₂的底物,可竞争抑制氯氮平的代谢;西咪替丁是一种非选择性抑制剂,亦可影响其代谢。

参考文献

- 1 吴天诚,唐桂蓉.精神分裂症男女住院病人抗精神病药物治疗的现状分析[J].临床精神医学杂志,1996,6(2):82
- 2 侯静.影响氯氮平药代动力学的物质[J].国外医学精神病学分册,1998,25(3):179
- 3 钱敏才.传统与新型抗精神病药所致非锥外副反应[J].国外医学精神病学分册,1998,25(2):78
- 4 彭斌.心境稳定剂的联合应用.国外医学精神病学分册[J].1998年,25(3):167
- 5 李明亮,庞建立.氯丙嗪或/和氯氮平加用卡马西平对精神运动性兴奋状态患者的睡眠及疗效的影响[J].中原精神医学杂志,1997,3(4):218
- 6 叶显撑,王洪泉.选择性5-羟色胺再摄取抑制剂与药物的相互作用[J].中国医院药学杂志,1998,18(9):416
- 7 临床精神医学杂志编辑部.氯氮平的副反应及其处理[J].临床精神医学杂志,1998,8(2):122
- 8 临床精神医学杂志编辑部.精神药物副反应及其处理[J].临床精

神医学杂志,1998,8(3):185

郭泉涌.利培酮(Risperidone)介绍[J].临床精神医学杂志,1998,8(增刊):39

杨旭,行养玲,贾伟等.氯氮平与氯丙嗪联合应用治疗精神分裂症阳性症状的对照研究[J].上海精神医学,1994,新6(2):71

刘义兰.氯丙嗪与氯氮平合用问题[J].上海精神医学,1994,新6(2):118

喻东山,高士衡,殷希全.合并用药对氯氮平血浓度的影响[J].临床精神医学杂志,1996,6(4):255

黄竹民,朱毅平,俞柏润等.吸烟与非吸烟精神分裂症患者氯氮平血浓度及疗效的相关研究[J].临床精神医学杂志,1996,6(1):5

陈加美,朱毅平,吴金根.月经周期对氯氮平血药浓度的影响[J].临床精神医学杂志,1998,8(4):207

临床精神医学杂志编辑部.氯氮平的不良反应[J].临床精神医学杂志,1998,8(1):55

收稿日期:1999-03-16

80例临床药学咨询分析

刘经森,刘莉萍,秦厚生,高浩挺 (中国人民解放军核工业 415 医院,湖南 衡阳 421002)

中图分类号:R969 文献标识码:A 文章编号:1001-5213(2000)04-0235-02

随着临床药学的发展,药物信息咨询工作日益重要。临床药师向临床人员介绍国内外新药、药物的合理使用、药物配伍禁忌、相互作用、药物不良反应、药物中毒与抢救等情报信息,已成为提高临床用药水平不可缺少的途径。近几年来我院临床药学研究室逐步开展了临床药学咨询工作,累计有 80 例,现对其进行回顾性分析如下。

1 方法与结果

对 80 例咨询按咨询者身份、答复者身份、咨询内容、咨询病例所在科室分类统计其分布情况,结果如下。

1.1 咨询者身份 详见表 1。

1.2 答复者身份 均为临床药学研究室中药师以上职称人员,详见表 2。

1.3 咨询问题 以临床选药居多(包括调整给药方案者),不良反应居次,详见表 3。

表 1 80 例咨询的咨询者身份分布

咨询者身份	例数	构成比/%	咨询者身份	例数	构成比/%
主任医生	18	22.5	护士	9	11.25
副主任医生	24	30.0	患者	10	12.5
主治医生	15	18.75	其他	2	2.5
住院医师	2	2.5			

表 2 80 例咨询的答复者身份分布

答复者身份	例数	构成比/%	答复者身份	例数	构成比/%
主任药师	45	56.25	主管药师	5	6.25
副主任药师	24	30.0	药师	6	7.5

表 3 80 例咨询内容分布

咨询内容	例数	构成比/%	咨询内容	例数	构成比/%
临床选药	27	33.75	用法用量	8	10.0
不良反应	24	30.0	药物成分	3	3.75
相互作用	10	12.5	其他	8	10.0

1.4 咨询病例 咨询病例的所在科室涵盖了本院绝大部分临床科室,其中内科病例居多,外科次之,详见表 4。

2 讨论

从表 1 可看出,咨询者以临床医务人员占绝大多数(85%),这说明当前最迫切需要药物咨询服务的仍是医务人员,这跟药学发展日新月异有密切的关系;从另一方面也说明我院药学咨询服务仍停留在起步阶段,服务面比较窄,远

表 4 80 例咨询病例所在科室分布

科室	例数	构成比/%	科室	例数	构成比/%
内科	27	33.75	急诊科	2	2.5
外科	13	16.25	皮肤科	1	1.25
传染科	10	12.5	肿瘤科	1	1.25
儿科	10	12.5	其它	14	17.5
妇产科	2	2.5			

没有发挥我们的专业优势,药学咨询服务这一领域还大有潜力。从咨询者身份来看,副高以上职称占一半以上(52.5%),这说明所咨询的问题多为临床罕见且是难以解决的问题,这就给我们的咨询服务提出了很高的要求。基于此,我们规定答复者必须具备如下条件:(1)有扎实的药学专业基础理论知识;(2)能迅速有效地检索所需的文献资料并能作出科学的判断与综合;(3)能深入病房查看病历、药历,迅速找出问题实质;(4)有丰富的工作经验。故从表 2 可知,我院基本以副高以上职称的临床药师担当答复者(占 86.25%),这就保证我院的咨询服务迅速有效,为临床解决了不少疑难问题。咨询者中,2 例其他人员分别为医务科干事和卫校讲师,这说明药学咨询的服务对象不仅仅是医务人员和患者,还应该包括卫生行政管理人员、药学教育人员、药品销售人员及其他相关人员。

从表 3 可看出,当前药物治疗的难点仍然为临床选药(包括药物疗效不佳调整治疗方案等),这至少可说明这么几个问题:(1)对医生具有指导意义一类的书刊太少或更新不及时;(2)医生的在职教育不够或再教育效果不明显,使得医生难以获得新的药物治疗信息,药物治疗水平很难提高;(3)新药推广方式比较单一,医生得不到所需的药物情报资料,如新药的药物动力学数据及大规模的临床试验资料等。在所咨询的临床选药问题中,大部分是因为对药物了解得不够彻底,对治疗方案不敢确定而寻求帮助,或者是原先治疗方案不显效而要求调整给药方案。在 27 例临床选药的咨询中,有关抗菌药物的选用有 9 例,占 1/3。由于临床耐药菌的不断增多,抗菌药物的层出不穷,使得医生在众多抗菌药物中作出合理选择的难度越来越大。

在所咨询的问题中,药物不良反应占了 30%,其中大部